Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Mundo Novo
2ª Vara

Autos 0800977-71.2018.8.12.0016
Autor(es): Maria do Carmo Costa
Réu(s) Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Mundo Novo

Vistos...

I – RELATÓRIO

Maria do Carmo Costa, qualificada nos autos, ajuíza ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência em face do Município de Mundo Novo e Estado de Mato Grosso do Sul, objetivando que sejam os requeridos condenados ao fornecimento dos medicamentos Duloxetina 60mg, Pregabalina 75mg, Ciclobenzaprina 10mg e Glicosaminha 1.500mg + condroitina 1.200mg, de uso contínuo, na quantidade prescrita para o tratamento e conforme prescrição médica. Alega ser portadora de fibromialgia, poliartrose e episódios depressivos (CIDs 10 M79.7, M15.9 e F32), o que lhe provoca dor crônica, principalmente na coluna lombar e limitam suas atividades. Afirma que é atendida por especialista que lhe indicou os remédios citados, sem possibilidade de substituição, porque a autora já fez uso das medicações fornecidas pelo SUS (fluoxetina e amitriptilina), e não apresentou melhora. Alega que a falta de medicamento acarreta quadro doloroso, causando prejuízo à qualidade de vida da autora. Informa que os fármacos possuem alto custo para a requerente, que não tem condições financeiras de custeá-los mensalmente. Declara que fez pedido administrativo para concessão dos remédios, mas foi negado, o que não se justifica porque são imprescindíveis para sua saúde. Aduz que os requisitos previstos no REsp 1.657.156 estão preenchidos. Faz pedido de tutela provisória de urgência. Junta documentos.

O NAT foi desfavorável ao pedido da autora (f. 40-54).

Concessão de tutela provisória de urgência à f. 55-62.

Peça defensiva do Município de Mundo Novo à f. 94-116, na qual alegou preliminar de ilegitimidade. No mérito tratou do princípio da legalidade, separação dos poderes, reserva do possível em razão do limite orçamentário e da inconstitucionalidade da pena de sequestro. Pediu a extinção

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE BERTO DE ALMADA, liberado nos autos em 13/09/2018 às 13:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800977-71.2018.8.12.0016 e código HJNnPD7e.

do feito ou a improcedência dos pedidos da inicial.

Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação à f. 117-132, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que cabe à municipalidade fornecer os medicamentos que a parte autora pretende. Apontou que há tratamento disponível pelo SUS, que não foi testado de forma suficiente com a parte autora, tanto é que o NAT foi desfavorável ao pleito. Discorreu sobre a impossibilidade de prevalecer o laudo unilateral em face do Poder Público. Verberou sobre o SUS e seu regramento. Na eventualidade apontou que em caso de condenação não pode ser condenado a pagar custas e honorários a favor da Defensoria Pública. Defendeu a não aplicação de multa cominatória contra o ente público.

Réplica à f. 134-159.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório no que importa. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Preliminar:

Os réus sustentam cada qual que o outro réu é que deve arcar com o fornecimento dos medicamentos.

Todavia, o art. 23 da CRFB/88 dispõe que "é de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência".

No caso concreto saber se um ou outro réu é que deve arcar com o fornecimento do anódino é questão de mérito.

Rejeito as preliminares.

Tema 106

No julgamento do referido tema, foi firmada a seguinte tese:

"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE BERTO DE ALMADA, liberado nos autos em 13/09/2018 às 13:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800977-71.2018.8.12.0016 e código HJNnPD7e.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Mundo Novo
2ª Vara

> (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
> (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
> (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento."

No referido julgamento foi realizada modulação de efeitos, de modo que os requisitos estabelecidos somente devem ser analisados nos feitos distribuídos a partir da conclusão do referido tema[1]. Assim, considerado que este feito foi distribuído em 22.05.2018, é o caso dos autos.

Mérito:

No que tange ao mérito propriamente dito a parte autora cita artigos constitucionais que lhe garantem o tratamento, que depende dos remédios que pede, e alega haver solidariedade entre União, Estados e Municípios em proporcionar o direito à saúde.

Pelo Estado de Mato Grosso do Sul, ao contrário, afirmou que nenhum direito é absoluto e daí que, se os remédios solicitados não estão padronizados na Relação Nacional de medicamentos essenciais – RENAME, não são disponibilizados pela rede pública de saúde e, como consequência, havendo drogas semelhantes ofertadas, ao paciente incumbe, se quiser, valer-se delas, pois perante o SUS não cabe a escolha de tratamento. A defesa do Município de Mundo Novo seguiu na mesma linha.

Pois bem.

O ordenamento jurídico brasileiro tutela o direito à saúde, determinando o artigo 196 da Constituição Federal que:

> "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Por sua vez, a Lei n.º 8.080/90, que trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, estatui que:

[1] **Modulação de efeitos**: "Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que **os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento.**" (trecho do acórdão publicado no DJe de 04/05/2018)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE BERTO DE ALMADA, liberado nos autos em 13/09/2018 às 13:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800977-71.2018.8.12.0016 e código HJNnPD7e.

> "Art. 2.º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício."
> "Art. 7.º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde – SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
> I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
> II – integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
> IX – descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;".

Destarte, de acordo com as normas constitucionais e legais, cabe ao Estado e ao Município prestar toda a assistência necessária à saúde dos cidadãos que se utilizem do Sistema Único de Saúde, na forma regular em que possam surtir os efeitos necessários.

Basta o dispositivo previsto no texto constitucional citado para se chegar à conclusão de que se deve garantir o direito de todos à saúde. As normas infraconstitucionais, que procuram dar efeito integrador ao texto constitucional, seriam até despiciendas se existisse a consciência, por parte de todos os responsáveis pela administrações dos entes federados, de que a Constituição Federal não é puramente analítica. A Constituição, com sua força normativa, constitui energia que deve influir na realidade. O dever da Administração de adquirir o necessário ao atendimento de pessoas doentes, imposto pela Constituição, não pode ser inviabilizado eventualmente através de entraves burocráticos e questiúnculas referentes à competência deste ou daquele órgão para distribuição. A distribuição de competências entre os entes federados é firmada para melhor servir aos cidadãos e não para aumentar seus sofrimentos e angústias, motivo pelo qual há solidariedade entre eles.

Assim, não prospera qualquer argumento de que se o material/medicamento pretendido não constar nem na relação de básicos - de competência do Município - nem na de medicamentos excepcionais - de competência do Estado – esvazia SEMPRE o dever, porque acima dos critérios de distribuição administrativa de competências está a saúde dos cidadãos que necessitam fazer uso de material essencial. Aliás, o julgamento do tema 106 pelo STJ deixa clara essa possibilidade, mas apenas e tão somente quando haja prova robusta de que as possibilidades da rede pública não são eficazes, <u>o que restou demonstrado no caso em tela, conforme se verá com a fundamentação que</u>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE BERTO DE ALMADA, liberado nos autos em 13/09/2018 às 13:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800977-71.2018.8.12.0016 e código HJNnPD7e.

segue.

Não cabe falar em violação aos princípios da isonomia e da separação de poderes, pois a conclusão exposta de forma alguma exclui a obrigação dos réus com os demais cidadãos, que ao necessitarem de tratamento de saúde poderão procurá-los para tanto. Outrossim, descabida a alegada usurpação da função executiva pelo Poder Judiciário, vez que é garantia fundamental a inafastabilidade da jurisdição (CRFB, art. 5º, XXXV), de modo que o cidadão ao ter direito seu malferido pelo Poder Público tem plena possibilidade de postular a efetivação de seus direitos, sobretudo constitucionais, como é o caso dos autos, perante o Poder Judiciário. Admitir a tese contrária importa em esquecer a mais básica razão da separação de poderes, consubstanciada no famoso sistema de "freios e contrapesos", ou seja, a sua limitação, de modo que não possa agir ao seu talante, de forma arbitrária, sem atender à sua finalidade. Aliás, há mais de dois séculos Montesquieu já dizia: *"todo aquele que tem poder e não encontra limites tende a dele abusar".*

Não se poderia aceitar, principalmente porque se cuida de questão atinente à saúde, que, por questões administrativas, fique o necessitado desprovido da possibilidade de ver atendida sua necessidade premente, como no caso. Solar, portanto, é o direito do cidadão em obter do ESTADO (em sentido amplo) o medicamento conforme requerido e segundo critério médico. É o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, senão observe-se (sem grifo no original):

> "CONSTITUCIONAL – RECURSO ORDINÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO (INTERFERON BETA). PORTADORES DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE (CF, ARTS. 6.º E 189). PRECEDENTES DO STJ E STF.
> É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos o direito fundamental à saúde constitucionalmente previsto.
> Eventual ausência do cumprimento de formalidade burocrática não pode obstaculizar o fornecimento de medicação indispensável à cura e/ou a minorar o sofrimento de portadores de moléstia grave que, além disso, não dispõem dos meios necessários ao custeio do tratamento.
> Entendimento consagrado nesta Corte na esteira de orientação do Egrégio STF.
> Recurso ordinário conhecido e provido".

E o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AgRRe n.º 271.286-8/RS, decidiu na linha do entendimento supra. Colho, por ser oportuno, trecho do voto do Ministro Celso de Melo, o qual bem delineia a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE BERTO DE ALMADA, liberado nos autos em 13/09/2018 às 13:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800977-71.2018.8.12.0016 e código HJNnPD7e.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Mundo Novo
2ª Vara

questão:

> "Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a todos, a proteção à saúde, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que este atue no plano de nossa organização federativa.
> A impostergabilidade da efetivação desse dever constitucional desautoriza o acolhimento do pleito recursal ora deduzido na presente causa.
> Tal como pude enfatizar, em decisão por mim proferida no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao da presente causa (Pet 1.246-SC), entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5.º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que tem acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes...Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, gravíssima obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde incumbindo-lhe promover, em favor das pessoas e das comunidades medidas - preventivas e de recuperação -, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República...
> Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito - como o direito à saúde - do cidadão de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento constitucional".

E outro não tem sido o entendimento de nosso Tribunal de Justiça há bastante tempo:

> "MANDADO DE SEGURANÇA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - GARANTIA CONSTITUCIONAL - EFETIVIDADE DO DIREITO. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política — que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro — não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado." (Mandado de Segurança - N.º 2001.000020-5 - REL. Exmo. Sr. Des. Atapoã da Costa Feliz - J. 19/04/2001 - DJ-MS, 29/06/2001).
>
> "AÇÃO **CIVIL** PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SITUAÇÃO CONCRETA DE RISCO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – REQUISITO NÃO VERIFICADO – AGRAVO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE BERTO DE ALMADA, liberado nos autos em 13/09/2018 às 13:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800977-71.2018.8.12.0016 e código HJNnPD7e.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Mundo Novo
2ª Vara

> IMPROVIDO.
> Nega-se provimento ao agravo tirado da decisão que deferiu apenas em parte a antecipação de tutela jurisdicional reclamada para compelir municipalidade a disponibilizar medicamentos aos necessitados e, por conseguinte, contemplou com a medida excepcional apenas o beneficiário determinado, se verificado que em relação aos demais, indeterminados, o risco de ineficácia da prestação jurisdicional definitiva é somente hipotético e não efetivo." (Agravo - N. 2003.011736-9/0000-00 - Ponta Porã. Rel. Exmo. Sr. Des. Elpídio Helvécio Chaves Martins. Decisão Unânime e contra o parecer. Em, 23 de março de 2004.).

Estabelecida a responsabilidade dos réus em fornecer os medicamentos necessários ao tratamento da parte autora, cumpre a análise específica do caso concreto.

Consoante os autos, a autora alega que possui fibromialgia, poliartrose e episódios depressivos (CIDs 10 M79.7, M15.9 e F32), o que lhe provoca dor crônica, principalmente na coluna lombar e limitam suas atividades e por causa dessas doenças a médica que a assiste indicou os seguintes remédios: Duloxetina 60mg, Pregabalina 75mg, Ciclobenzaprina 10mg e Glicosaminha 1.500mg + condroitina 1.200mg, sendo que outros remédios não produzem o efeito esperado.

O laudo do NAT foi desfavorável. De acordo com referido núcleo a Duloxetina é um antidepressivo, Pregabalina um anticonvulsivante, Ciclobenzaprina um relaxante muscular e Glicosaminha + condroitina constituem outros produtos com ação no sistema músculo esquelético, são todos registrados na Anvisa.

Ainda segundo NAT (f. 48-49) a duloxetina é similar a pregabalina e por isso não é recomendada pelo Protocolo Clínico de Dor Crônica e "*em uma revisão sistemática que comparou os medicamentos duloxetina, escitalopram, fluoxetina, lorazepam, paroxetina, pregabalina, sertralina, tiagabina, e venlafaxina para o tratamento da ansiedade, mostrou que o medicamento mais eficaz foi a fluoxetina. No entanto, dada a qualidade desconhecida dos estudos incluídos e os riscos potenciais de erro e viés nos processos de revisão, suas conclusões devem ser interpretadas com cautela."* Segue o parecer: *"Para o tratamento da fibromialgia, uma revisão da literatura relata que a fisioterapia tem importante papel na diminuição do impacto dos sintomas na vida dos pacientes por meio de várias abordagens terapêuticas, melhorando a sua capacidade funcional e contribuindo para a manutenção de sua qualidade de vida. No tratamento medicamentoso, o Consenso Brasileiro do Tratamento da Fibromialgia informa que dentre os compostos tricíclicos, a amitriptilina, e entre os*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE BERTO DE ALMADA, liberado nos autos em 13/09/2018 às 13:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800977-71.2018.8.12.0016 e código HJNnPD7e.

relaxantes musculares, a ciclobenzaprina, reduzem a dor e frequentemente melhoram a capacidade funcional estando, portanto, recomendadas para o tratamento da fibromialgia (grau de recomendação A, nível de evidência Ib)." (negrito nosso)

Quer dizer, pelo que foi dito pelo Núcleo de Apoio Técnico os dois primeiros medicamentos solicitados são similares e outros de mesma eficácia são fornecidos pelo SUS, indicando como o melhor deles a fluoxetina, além da amitriptilina e a ciclobenzaprina.

Mas pela autora foi juntado o atestado médico de f. 16, que além de prescrever os remédios indicados, deixou claro que *fluoxetina e amitriptilina* não implicaram na melhora clínica desejada, enquanto que a ciclobenzaprina foi outro medicamento receitado.

Se fluoxetina e amitriptilina, pelo trecho acima, seriam as substitutas de Duloxetina 60mg e Pregabalina 75mg, mas já demonstrada a ineficácia delas, não há de ser autorizada a substituição.

Ciclobenzaprina, conforme já transcrito, trata-se de um relaxante muscular e nos moldes do parecer anexo, a fisioterapia tem importante papel na diminuição do impacto dos sintomas da vida dos pacientes com fibromialgia e para tratamento medicamentoso o Consenso Brasileiro informa que *"dentre os compostos tricíclicos, a amitriptilina reduz a dor e frequentemente melhora a capacidade funcional estando, portanto, recomendada para o tratamento da fibromialgia (grau de recomendação A, nível de evidência Ib). A nortriptilina foi recomendada pelo grupo para o tratamento da fibromialgia, ao contrário da imipramina e da clomipramina que não foram recomendadas (grau de recomendação D) (Grupo I SBR). Entre os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, houve consenso de que a fluoxetina em altas doses (acima de 40 mg) também reduz a dor e frequentemente melhora a capacidade funcional sendo também recomendada para o tratamento da fibromialgia (grau de recomendação A, nível de evidência Ib)"* e *"no tratamento medicamentoso, o Consenso Brasileiro do Tratamento da Fibromialgia informa que dentre os compostos tricíclicos, a amitriptilina, e entre os relaxantes musculares, a ciclobenzaprina (...)" (f. 49-50).*

Novamente *aparece a amitriptilina e a fluoxetina, ineficazes para a autora, segundo atesta a médica responsável,* ao mesmo tempo que é indicado pela comunidade médica a ciclobenzaprina, o mesmo requerido nos autos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE BERTO DE ALMADA, liberado nos autos em 13/09/2018 às 13:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800977-71.2018.8.12.0016 e código HJNnPD7e.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Mundo Novo
2ª Vara

Por fim, a Glicosaminha + condroitina *"é indicado para osteoartrite, osteoartrose ou artrose em todas as suas manifestações (f. 51)"* e *não possui genérico.*

Em suma, apesar de existirem medicamentos fornecidos pelo SUS que em tese trariam o mesmo resultado à autora, esta demonstrou que estes outros, mais sugeridos, já foram usados e não tiveram o resultado almejado. Trata-se de ponto crucial esta comprovação.

Também está clara sua hipossuficiência financeira, tanto que assistida pela Defensoria Pública e pelo extrato de f. 21, que demonstra perceber benefício previdenciário com valor liquido inferior a um salário mínimo, além de que todas as drogas solicitadas são registradas na Anvisa.

Assim, a improcedência é a medida adequada, pois foram preenchidos os requisitos cumulativos para concessão de medicamentos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, quais sejam:

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
c) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Por fim, apenas no que pertine aos honorários advocatícios, tenho que assiste razão ao Estado de Mato Grosso do Sul, pois, sendo a parte autora defendida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, que é um órgão do próprio Estado, não se afigura factível condená-lo a pagar verbas de sucumbência em favor de seu próprio órgão.

Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado:

> RECURSO OBRIGATÓRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ACOLHIDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR – RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PROVIDOS.A Defensoria Pública é órgão do Estado, por isso não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a fazenda em causa patrocinada por Defensor Público. Aplicação do art. 381 do Código Civil, no sentido de que há confusão entre a pessoa do credor e a do devedor, visto que a Fazenda Pública não poderá ser reconhecida como

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE BERTO DE ALMADA, liberado nos autos em 13/09/2018 às 13:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800977-71.2018.8.12.0016 e código HJNnPD7e.

> obrigada para consigo mesma.Recursos parcialmente conhecidos e providos. (TJMS, 1ª Turma Cível, rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, julgado em 10.11.2009)

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 421, reproduzida na peça de defesa do Estado de Mato Grosso do Sul, consolidando este entendimento. De outro lado, perfeitamente possível a condenação do Município de Mundo Novo a favor da Defensoria Pública.

Por derradeiro, nada há de inconstitucional na pena de sequestro, como alega o réu, uma vez que a medida só se concretizará se a ordem judicial for descumprida pelo ente federado.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvo o mérito da demanda na forma do art. 487, I, do CPC, para JULGAR PROCEDENTE o pedido apresentado com a inicial para o fim de determinar que os réus forneçam à autora *Duloxetina 60mg, Pregabalina 75mg, Ciclobenzaprina 10mg e Glicosamina 1.500mg + condroitina 1.200mg*, de uso contínuo, na quantidade prescrita para o tratamento, conforme prescrição médica. Os remédios devem ser fornecidos até o dia 05 de cada mês, sob pena de multa de R$ 500,00 caso ultrapassado o dia indicado sem entrega dos medicamentos à autora.

Confirmo a tutela de urgência. Sem custas, *ex vi legis*.

Condeno o Município de Mundo Novo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Havendo o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Mundo Novo, 13 de setembro de 2018.

Guilherme Henrique Berto de Almada
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE BERTO DE ALMADA, liberado nos autos em 13/09/2018 às 13:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800977-71.2018.8.12.0016 e código HJNnPD7e.